



PLANILLA DE SUSPENSIÓN DE ACENOCUMAROL CON PUENTE DE ENOXAPARINA

Uso individual – completar según fecha operatoria, dosis y criterio médico

Paciente:		Médico:	
DNI:		INR previo:	
Procedimiento:		Riesgo trombótico:	Bajo / Intermedio / Alto ▼
Fecha de cirugía:		Observaciones:	

PLAN DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

Día -5	Día -4	Día -3	Día -2	Día -1	Día 0	Día +1	Día +2	Día +3	Día +4
									
Tomar acenocumarol	Tomar acenocumarol	NO tomar acenocumarol	NO tomar acenocumarol	Enoxaparina 08:00 a.m.	Cirugía / Quirófano	Reiniciar enoxaparina	Continuar enoxaparina	Acenocumarol + enoxaparina	Suspender puente según INR
- Última dosis según esquema. - Controlar INR previo según indicación.	- Continuar acenocumarol. - Controlar INR si corresponde.	- Suspender acenocumarol. - NO iniciar enoxaparina.	- Mantener suspensión de acenocumarol. - NO iniciar enoxaparina.	Aplicar enoxaparina según dosis (1 mg/kg c/12 h o dosis profiláctica según indicación).	- NO administrar enoxaparina. - Procedimiento según equipo tratante.	- Reiniciar enoxaparina según hemostasia. - Habitualmente 24 h postcirugía (si no hay sangrado).	- Mantener enoxaparina según dosis indicada. - Asociar acenocumarol en dosis habitual.	- Continuar ambos tratamientos. - Controlar INR y ajustar dosis de acenocumarol según resultado.	- Suspender enoxaparina si INR en rango terapéutico (según indicación). - Continuar acenocumarol.
Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:	Dosis / Hora:



Recordatorio: individualizar la conducta según riesgo trombótico, riesgo hemorrágico, función renal y hemostasia postoperatoria.



Consultorio GHEMAS
Arrieta 1728,
Villa Luzuriaga



Consultorio Baruch
Agüero 1235,
Morón



Turnos / WhatsApp:
11 5403 0229

Fuentes orientativas: SAH – Guía de Hemostasia y Trombosis (2023); ASH; CHEST.
Adaptar siempre al paciente y al procedimiento.